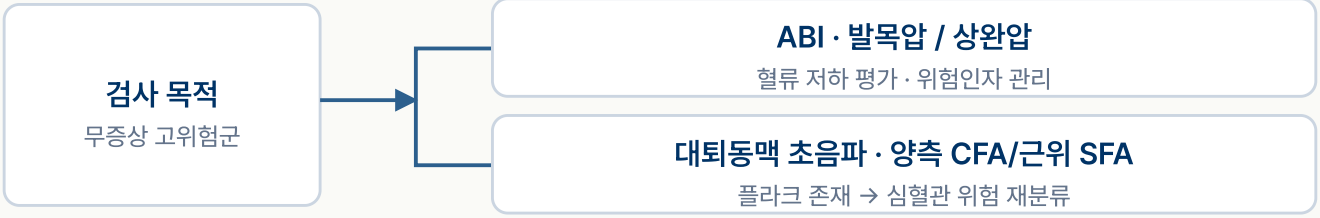
무증상 고위험군의 선택적 ABI와 대퇴동맥 플라크 평가

혈류 저하를 보는 ABI와 심혈관 위험 재분류를 위한 플라크 관찰의 목적을 구분한다.

핵심 판단 한눈에



ABI는 발목·상완 압력비, 대퇴동맥 초음파는 위험 재분류용 플라크 관찰에 사용한다.

연자 Q&A · 누구에게, 어디까지 볼 것인가

항목	Q&A 44쪽 답변
선택적 ABI	65세 이상, 50–64세이면서 당뇨·흡연·CKD·가족력, 당뇨병 또는 다른 부위 죽상경화증 환자
플라크 관찰 범위	양측 총대퇴동맥(CFA)·분지부·근위 표재대퇴동맥(SFA). 위험 재분류 목적이며 하지 전체 협착 검사를 뜻하지 않음
무증상 협착 ≥50%	먼저 ABI. ABI <0.9이면 의뢰해 병변 범위·추적 계획 수립. 무증상 협착 자체는 시술 대상이 아님
ABI 정상·무증상	스타틴 강화·정기 추적. 일반 인구 일괄검진과 고위험군 선택검사를 구분

강의 · ABI 수치와 증상을 함께 해석

압박이 잘 안 되거나 증상과 맞지 않을 때

발목동맥이 잘 압박되지 않으면 ABI >1.30으로 위음성이 가능하다. 당뇨·고령·투석 중 CKD·장기 스테로이드 복용을 살핀다. 휴식 때와 운동 후 재측정하여 발목압 20% 이상 감소, 회복 3분 이상 여부를 본다.

진찰·의뢰

- ☐ 흡연·당뇨·신부전 및 다른 혈관질환 병력을 기록한다.
- ☐ 대퇴·슬와·족배·후경골동맥 맥박을 좌우 비교한다.
- ☐ 상처·휴식기 통증이 있으면 ABI 결과와 관계없이 의뢰한다. 연자 Q&A 43쪽